SFSEP Société Francophone de la Sclérose En Plaques

Infections urinaires et sclérose en plaques

Recommandations de la Société Francophone de la Sclérose en Plaques - Septembre 2020 endorsées par la SPILF

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1878776220300698

Téléchargement de l'application SFSEP disponible sur App et Google store

Diaporama réalisé par le groupe Recommandations de la SPILF le 18 novembre 2020

Epidémiologie

- Troubles vésico-sphinctériens chez 50-90% des patients avec un délai d'apparition ~ 6 ans.
- Complications urologiques les plus fréquentes : IU
  - 30% cystites
  - 8% de pyélonéphrites et infections urinaires masculines fébriles.
- Facteurs de risque spécifiques d'IU :
  - troubles de la vidange urinaire (résidu post-mictionnel > 120cc),
  - pressions de remplissage vésical élevées,
  - durée de maladie > 15 ans,
  - Expanded Disability Status Scale (EDSS) élevé,
  - antécédent de lithiases urinaires,
  - antécédent de sondage vésical à demeure.

Les IU sont-elles associées à un risque accru de déclenchement de poussée ou d'aggravation transitoire ou prolongée de l'incapacité ?

- Les IU ne sont pas associées à un risque accru de survenue
  - d'une **poussée** de SEP
  - d'une **aggravation prolongée** de l'incapacité.

- Les IU non fébriles ne sont pas associées à un risque accru de survenue d'une **aggravation transitoire** de l'incapacité.

- Les IU fébriles sont associées à un risque accru **d'aggravation transitoire** de l'incapacité.

SFSEP Société Francophone de la Sclérose En Plaques

Le risque infectieux urinaire est-il accru par les traitements de la SEP ?

- Aucune augmentation du risque infectieux urinaire n'a été établie pour les molécules suivantes :

Interféron bêta
Acétate de glatiramer
Tériflunomide
Diméthylfumarate
Fingolimod
Cladribine
Natalizumab
Mycophénolate mofétil
Azathioprine
Echanges plasmatiques
Méthylprednisolone
Fampridine

Le risque infectieux urinaire est-il accru par les traitements de la SEP ?

- Une augmentation du risque infectieux urinaire a été identifié avec les molécules suivantes :

	Commentaires
Mitoxantrone	Etudes anciennes avec EDSS élevée
Alemtuzumab	Dans les 2 années qui suivent l'introduction
Ocrelizumab	Si hypogammaglobulinémie associée par extension à l'effet de classe des anti-CD20
Cyclophosphamide	Données très hétérogènes
Rituximab	

Faut-il traiter une bactériurie asymptomatique ?

- Il est recommandé de ne pas dépister ni traiter systématiquement une bactériurie asymptomatique (colonisation urinaire) à l'exception des situations recommandées dans la population générale : grossesse et chirurgie au contact de l'urine.

- Il est recommandé de ne pas dépister ni traiter systématiquement une bactériurie asymptomatique (colonisation urinaire) avant un traitement immunosuppresseur.

Le traitement est à discuter au cas par cas en cas d'hypogammaglobulinémie.

- Il est recommandé de dépister et traiter une bactériurie asymptomatique avant bilan urodynamique uniquement en présence de facteurs de risque connus d'IU :
  - IU récidivantes
  - reflux vésico-urétéral
  - pression intra-détrusorienne > 40cm d'eau.

Faut-il traiter une bactériurie symptomatique ?

- Il est recommandé de traiter un patient présentant des symptômes, en présence d'une vessie neurologique ou non et quel que soit le mode mictionnel (miction volontaire/sondage).

- Le traitement des IU suivra les recommandations de la population générale.

- Prévention des IU à répétition :

  - Il est recommandé de proposer un bilan en neuro-urologie,

  - Par analogie avec les blessés médullaires, un antibiocycle hebdomadaire alterné peut être discuté sur avis spécialisé,

  - Le bénéfice des médecines alternatives complémentaires (acidification des urines, cranberries, méthénamine, D-mannose) n'a pas été établi,